Клинические рекомендации

Деформация перегородки носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J34.2** — Смещенная носовая перегородка
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.05.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/913_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология 2

2.3 Классификация 2

2.4 Клиническая картина 3

3. Диагностика 3

3.1 Передняя риноскопия 3

3.2 Эндоскопия полости носа и носоглотки 3

3.3 Рентгенография или КТ околоносовых пазух 3

4. Лечение 4

4.1 Хирургическое лечение 4

4.2 Послеоперационное ведение 4

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 4

5.1 Показания к госпитализации 4

5.2 Наблюдение и профилактика 5

6. Источник и актуальность 5

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 5

1. Основные положения

- Деформация перегородки носа: смещение перегородки от средней линии с нарушением носового дыхания. Основной жалобой является стойкое одно- или двустороннее затруднение носового дыхания.
- Диагноз устанавливается по жалобам, данным передней риноскопии и эндоскопии полости носа. Перед операцией выполняется рентгенография или КТ околоносовых пазух, детям и подросткам — КТ.
- Лечение хирургическое: септопластика, в том числе эндоскопическая. У детей из-за ростковых зон соблюдается щадящий подход.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Деформация перегородки носа: анатомическое изменение строения и положения перегородки относительно средней линии, вызывающее нарушение носового дыхания. Синонимы: девиация, искривление перегородки носа.

2.2 Этиология

Деформация перегородки носа без участия травмирующего агента может сформироваться вследствие дисбаланса развития в пренатальном периоде, при прохождении по родовым путям, а также в периоды активного роста, когда костно-хрящевой остов перегородки растёт быстрее, чем кости свода и дна полости носа.

Деформация может сформироваться и вследствие травмы; вид деформации при этом зависит от вида и механизма травмы. У детей этиология деформации преимущественно нетравматическая.

2.3 Классификация

Рекомендуемая унифицированная классификация:

1. С-образная девиация;
2. S-образное искривление;
3. гребень;
4. вывих четырёхугольного хряща;
5. утолщение («бугор»).

Известны также классификации Cottle, Mladina, А. С. Лопатина и Г. З. Пискунова.

2.4 Клиническая картина

Перегородка смещена от средней линии, изменена её форма. Основной симптом — одно- или двустороннее затруднение носового дыхания.

Возможные сопутствующие симптомы

1. гипо- или аносмия;
2. храп, апноэ сна;
3. ксеростомия, сухость слизистой носа;
4. деформация наружного носа;
5. рецидивирующие носовые кровотечения;
6. рецидивирующие риносинуситы;
7. стекание слизи по задней стенке глотки;
8. закрытая гнусавость;
9. рецидивирующая головная боль по типу головной боли напряжения.

---

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. жалобы на стойкое одно- или двустороннее нарушение носового дыхания;
2. передняя риноскопия: девиация и смещение перегородки, изменение внутриносовой анатомии, субтотальная или тотальная назальная обструкция;
3. эндоскопия полости носа, рентгенография или КТ околоносовых пазух: деформация перегородки и других внутриносовых структур.

У детей без сформированной речи затруднение носового дыхания оценивают со слов родителей или опекуна.

3.1 Передняя риноскопия

Выполняется всем пациентам с затруднением носового дыхания при первичном осмотре оториноларинголога.

Оценивают

1. перегородку и её положение;
2. нижние и средние носовые раковины;
3. состояние слизистой оболочки.

Лабораторные и иные исследования для первичной диагностики не показаны.

3.2 Эндоскопия полости носа и носоглотки

Выполняется всем пациентам при наличии оборудования: показывает локализацию деформации, изменения других внутриносовых структур и состояние носоглотки.

3.3 Рентгенография или КТ околоносовых пазух

Показания

1. деформация перегородки: анатомия пазух, планирование операции, сопутствующая патология — хронический синусит, новообразования, инородные тела.

Детям и подросткам перед операцией — КТ околоносовых пазух обязательно.

4. Лечение

4.1 Хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению

1. стойкое затруднение носового дыхания, вызванное деформацией перегородки носа;
2. деформация подтверждена риноскопией или эндоскопией полости носа и носоглотки;
3. деформация подтверждена рентгенографией или КТ околоносовых пазух.

Методом лечения является септопластика или пластика перегородки носа с эндоскопической поддержкой; её цель состоит в восстановлении носового дыхания.

Дети и подростки

1. щадящий подход: минимальная резекция, бережность в проекции сфенодорсальной и сфеноостевой ростковых зон;
2. избыточная резекция в передних отделах и повреждение ростковых зон ведут к деформации наружного носа и средней трети лица;
3. интраоперационно — эндоскопическая или микроскопическая визуализация;
4. хирургическое лечение детей **младше 12 лет** возможно в учреждениях третьего уровня.

Риносептопластика, в том числе эндоскопическая, совместно с пластическим хирургом

1. выраженная деформация перегородки и костей носа;
2. выраженное каудальное искривление;
3. деформация в верхних отделах перегородки;
4. высокий риск неудовлетворительного результата или неполной коррекции при септопластике.

4.2 Послеоперационное ведение

Отсасывание слизи из носа: всем пациентам для очищения носовых ходов от фибрина, слизи и крови и профилактики синехий.

Септальные шины: по индивидуальным показаниям для профилактики синехий.

Препараты для улучшения носового дыхания, кратковременно: ксилометазолин, фенилэфрин, оксиметазолин, в том числе в комбинациях. Дозы по инструкции.

Орошение полости носа: всем пациентам солевыми растворами или стерильной морской водой для удаления фибрина и отделяемого. По индивидуальным показаниям возможны другие препараты.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Плановая госпитализация показана для хирургического лечения; показания к нему приведены в разделе «Хирургическое лечение».

Показания у детей

1. стойкое одно- или двустороннее затруднение дыхания и (или) апноэ сна, не связанные с другими причинами, со слов родителей;
2. деформация подтверждена эндоскопией полости носа и носоглотки и КТ околоносовых пазух.

Выписка

1. нет гнойного воспаления в полости носа;
2. нет местных и системных осложнений.

5.2 Наблюдение и профилактика

Конкретных рекомендаций о наблюдении нет; по клиническому опыту — плановые осмотры **в течение первого года** после операции. Медицинская реабилитация не показана.

Профилактика у детей

1. социальные меры по профилактике травматизма: безопасный досуг детей и подростков, безопасность дорожного движения;
2. разъяснительная работа с родителями в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях: возможность сопутствующих заболеваний и необходимость своевременного хирургического лечения.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Деформация перегородки носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 20.05.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее мая 2028 года
Код в рубрикаторе	`913_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.